

Impact des psychotropes sur la tension artérielle

 Les médicaments psychotropes peuvent modifier la tension artérielle (TA), le plus souvent en la diminuant (hypotension), parfois en l'augmentant (hypertension, HTA). En général, ces effets sont sans gravité, mais ils nécessitent une surveillance en particulier chez les personnes âgées.

 Ces effets sur la TA sont surtout observés pour les psychotropes impactant les systèmes de transmission noradrénergiques, qui contrôlent la contraction des vaisseaux sanguins, ainsi que la fréquence et l'intensité des contractions cardiaques.

 L'hypotension dite « orthostatique » ou posturale est l'effet indésirable le plus fréquent.

 lorsqu'on passe rapidement de la position assise/couchée à debout, la TA baisse rapidement (systolique ≥ 20 mm Hg ou diastolique ≥ 10 mm Hg en moins de 3 mn)

 cette hypotension peut entraîner des étourdissements, vertiges, troubles de la vision, voire syncope (perte de connaissance).

 le risque principal est celui de chute et de fractures ; chez les femmes enceintes, cela peut entraîner une hypoperfusion du fœtus.

 Le risque d'hypotension orthostatique est présent avec :

 antidépresseurs :

- tous les tricycliques même à faibles doses
- la mirtazapine et la miansérine

 antipsychotiques

- surtout ceux dits « sédatifs » : lévomépromazine, cyamémazine
- mais aussi chlorpromazine, loxapine, rispéridone, palipéridone et quétiapine
- clozapine en début de traitement si l'introduction est trop rapide

 Le risque d'hypotension orthostatique augmente avec :

 l'âge

 la déshydratation

 la polythérapie de médicaments hypotenseurs (penser aux β - et α -bloquants parfois prescrits en psychiatrie)

 les comorbidités (maladie de Parkinson, diabète, etc.)

 Si on ne peut pas réduire/arrêter les médicaments en cause, la prise en charge repose sur

 règles posturales : changer très progressivement de position

 bas de contention

 exceptionnellement des traitements médicamenteux (fludrocortisone)

 L'HTA induite/aggravée par les psychotropes est plus rare. Elle concerne surtout :

 kétamine et eskétamine : un pic tensionnel parfois important survient 30-40 mn après l'administration, justifiant que ce traitement soit contre-indiqué en cas de risque d'hémorragie cérébrale

 psychostimulants : méthyphénidate, le plus souvent sans conséquence

💊 antidépresseurs

- inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA) : surtout venlafaxine à doses > 200 mg et duloxétine
- bupropion
- inhibiteurs sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS): très rare, essentiellement dans le cadre d'un syndrome sérotoninergique (urgence médicale avec fièvre, tachycardie, confusion, etc.)

💊 antipsychotiques

- indirectement via le syndrome métabolique
- de manière exceptionnelle, lors d'un syndrome post-injection avec le pamoate d'olanzapine.

🩺 Une surveillance régulière de la TA est justifiée pour tous ces traitements, surtout chez les personnes âgées et les femmes enceintes, et des adaptations de traitement si les effets sont importants.

Références

<https://doi.org/10.1007/s11906-020-01096-4>

<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003821>

